



8-4742-308-651

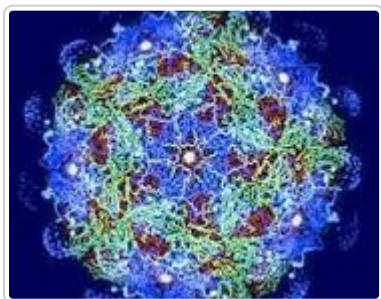
время работы с 8.00 до 17.00
перерыв с 12-00 до 13-00

МЕНЮ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ НАШИ УСЛУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ,
ИЗМЕРЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПАСНЫХ И ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИРОДНО - ОЧАГОВЫЕ
ИНФЕКЦИИ

Природно - очаговые инфекции

Что такое ящур и чем он опасен.



По данным Международного эпизоотического бюро в последние годы отмечается ухудшение эпизоотической ситуации по ящуру в мире. Крупные вспышки ящура были зарегистрированы в Монголии, Северной и Южной Корее, Японии, Тайване, Афганистане, Индии, Китае, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Турции. Имеется тенденция к осложнению эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, олени). Животноводству ящур наносит большой экономический ущерб. За считанные часы от одного больного животного могут заразиться сотни. Больные животные подлежат уничтожению.

Ящур (рыльно-копытная болезнь, афтозная лихорадка, эпизоотический стоматит) (Aphtae epizooticae)— острое вирусное высококонтагиозное заболевание из группы зоонозов (инфекционных болезней животных). Возбудитель ящура — фильтрующийся ультрамикроскопический вирус, относится к семейству Picornoviridae и является одним из наиболее мелких РНК-содержащих вирусов. Этот возбудитель инфекции характеризуется высокой изменчивостью и устойчивостью во внешней среде.

История изучения. Первое сообщение о заболевании животных ящуром сделано в Италии в 1546 году венецианским врачом Фракасторо. Впервые информация научного характера о ящуре у людей была опубликована в Норвегии в 1764 году Сагаром, который наблюдал более 1500 случаев ящура (афтозной ящурной лихорадки). В 1897 г. Ф. Леффлер и П. Фрош доказали вирусную природу возбудителя, они установили, что жидкость ящурных пузырьков проходит через бактериальные фильтры, сохраняя свою вирулентность.

Название болезни, по-видимому, русского происхождения, заимствованное из местного говора. Один из ведущих отечественных специалистов по ящуру профессор А.Л. Скоморохов в своей монографии «Ящур» (1952 г.) сообщает, что в отечественной литературе, начиная с первой половины XIX века, это заболевание описывается под названием «ящерокопытной» или «ящурокопытной» болезни скота. В Толковом словаре В.И. Даля (1882 г.) указывается: «Ящеръ — шероховатое воспаление языка у скота, трещины по языку». И далее: «Ящеръ — шероховатая кожа, кожа, обделанная сыпью». В переводе с английского название болезни звучит как «поражение конечностей и ротовой полости», с немецкого — как «поражение рта (морды) и

копыт». В связи с этим в дореволюционной литературе нередко ящур назывался «рыльно-копытной болезнью».

Основным источником и резервуаром вируса являются домашние и дикие копытные животные. Выделение возбудителя больными животными происходит с мочой, слюной, испражнениями, молоком. А несоблюдение правил личной гигиены при контакте с заболевшими животными может явиться причиной заражения людей.



Большое значение в распространении вируса ящура имеет человек, так как он чаще всего соприкасается с животными и может перемещаться на большие расстояния. Механически переносится вирус ящура с транспортом, птицей и другими видами невосприимчивых животных (в том числе и дикими), а также насекомыми и клещами.

Основной путь передачи ящура контактно-бытовой, инфицирование человека происходит при попадании вируса на поврежденную кожу или слизистую оболочку. Заражение может произойти при контакте с фуражом и различными предметами ухода за животными, а также при употреблении в пищу сырого молока и плохо прожаренного мяса от больных животных.



В клинической картине заболевание у людей протекает с явлениями афтозного стоматита (афты - поверхностные изъязвления, болезненные при контакте с какой-либо поверхностью, весьма затрудняющие акт жевания и глотания, также сопутствующим признаком является гиперсаливация (усиление слюноотечения)); герпетической ангины на фоне гриппоподобных состояний (головная и мышечная боль, в том числе в области поясницы); чувства жжения и сухости во рту; а также появления везикулезно-эрозивных (пузырьково-язвенных) поражений ногтевого ложа и кожи межпальцевых

складок. Вирус проникает в организм через слизистые оболочки полости рта (реже — пищеварительного и дыхательного тракта) и поврежденную кожу. В месте внедрения возбудителя возникает первичный аффект (очаг поражения) — небольшая везикула (пузырек), где вирус размножается и накапливается. Следующим этапом является вирусемия (проникновение вируса в кровь), приводящая к интоксикации. Выраженная дерматотропность вируса обуславливает его фиксацию в эпителии слизистых оболочек (полость рта, носа, уретры) и кожи (кисти и стопы), где отмечаются вторичные везикулы. С их появлением вирус в крови не обнаруживается. Выздоровление наступает обычно на 10 — 15-е сутки болезни. Больным ящуром независимо от тяжести заболевания необходимо проходить **лечение в условиях стационара**, где они должны находиться не менее 14 дней от начала болезни до полного клинического выздоровления, заживления язв на слизистых оболочках и коже.

Инфекция не передается от человека к человеку.

Профилактика. За счёт высокой контагиозности и устойчивости во внешней среде вирус не теряет своей актуальности и по сей день. Для предупреждения распространения ящура среди людей необходимо ликвидировать его среди животных, что достигается установлением строгих карантинных мероприятий (ограждения, дезинфекция транспорта, выезжающего за пределы очага, и т. д.). Лица, соприкасающиеся с больными животными, должны соблюдать ряд мер индивидуальной защиты: работать в спецодежде, не пить воду, не принимать пищу, не курить в очаге инфекции. Не допускаются к работе в неблагоприятных по ящуру хозяйствах беременные женщины, подростки и лица с микротравмами рук.

В России и некоторых других странах для профилактики ящура среди животных успешно используют инаktivированные вакцины, которые через 2–3 недели после прививки создают иммунитет к заболеванию.

Памятка населению:

- при выявлении внешних признаков заболевания у животных или их внезапной гибели, следует немедленно обращаться в государственную ветеринарную службу;
- не заниматься самолечением, при обнаружении трупа не подходить;
- не приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие местности и здоровье животных;
- по требованию ветеринарных специалистов предоставлять животных для проведения клинического обследования;
- оповещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретенных животных;

- о осуществление перемещения крупного рогатого скота по разрешению руководителя органа государственной ветеринарной службы.

**Внимание !
это важно**

В Н И М А Н И Е! Уважаемые Клиенты! с 11 августа 2026 по 25 августа 2026 года забор крови из вены проводиться не будет

11.08.2026



Всероссийская кампания #ПоднятьФлаг

21.08.2026



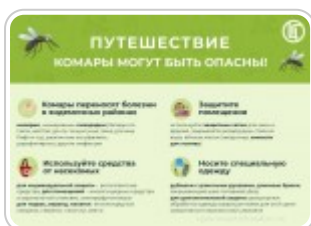
Итоги горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей

21.08.2026



Как выбрать средство от укуса комаров

20.08.2026



Комары, какие заболевания они переносят и как защититься

20.08.2026



Видео от Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области

19.08.2026



Яблочный спас. Как пектин помогает при кишечных инфекциях

19.08.2026



О мерах профилактики отравлений грибами

19.08.2026



Н.Н. Ладная: есть ли связь между временем года и риском заражения ВИЧ. Рассказывает эксперт проекта «Санпросвет»

18.08.2026



Педикулез: что важно знать

18.08.2026



Видео от Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области

17.08.2026



Купание под запретом: как понять, что водоем опасен для здоровья

17.08.2026



Популярные вопросы о вакцинации против гриппа

17.08.2026



Меры профилактики острых кишечных инфекций в летний период

17.08.2026



Безопасность детей летом

16.08.2026

[Больше полезной информации](#)

© Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области", 2014-2026 гг.

При использовании материалов сайта, ссылка на сайт обязательна.

Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а.

Телефон: +7 (4742) **308-651**

info@cge48.ru | [Контактная информация](#)